

PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS : ANALYSE DES INDICATEURS MONDIAUX DE L'OMS EN 2024 ET APPORT DES TECHNOLOGIES INNOVANTES POUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DE 2030

Auteur : ZITI Meriem (email : dr.ztmeriem@gmail.com, Tél : 06 64 36 97 34)

Coauteurs : L.KARA , Z.GUEZATI , M.CHOUBANE , H.MOUSSAOUI ,
R.BOUROUCHE , C.KADRI , S.ABBACHE , S.LAOUAMRI

Service d'Epidémiologie et de Médecine Préventive, CHU de Sétif
Université Ferhat Abbas Setif 1

INTRODUCTION

Les infections associées aux soins (IAS) constituent l'un des événements indésirables les plus fréquents en milieu hospitalier, touchant près d'un patient hospitalisé sur dix dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les interventions de prévention et contrôle des infections (PCI) peuvent réduire jusqu'à 70 % des IAS.

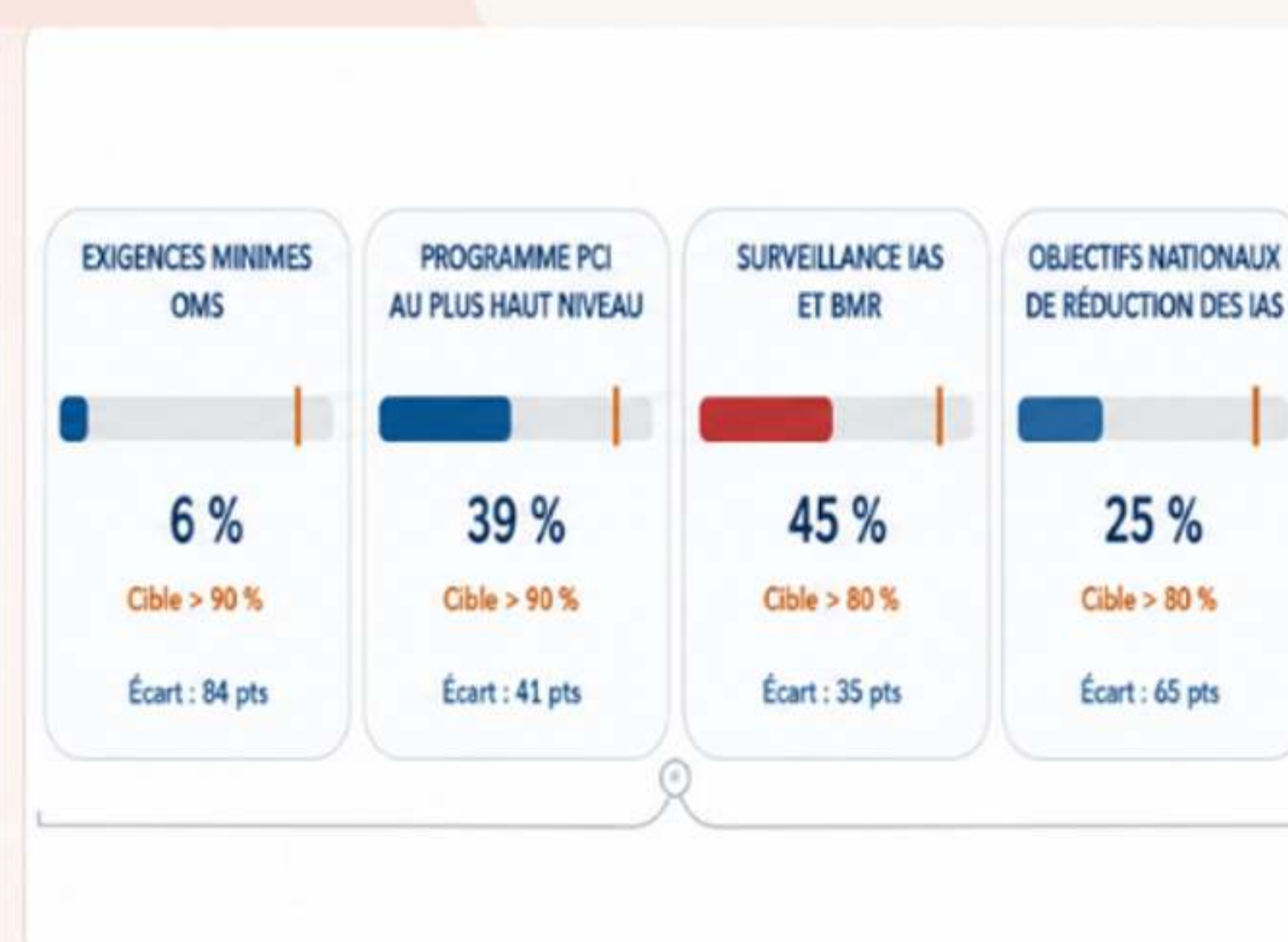
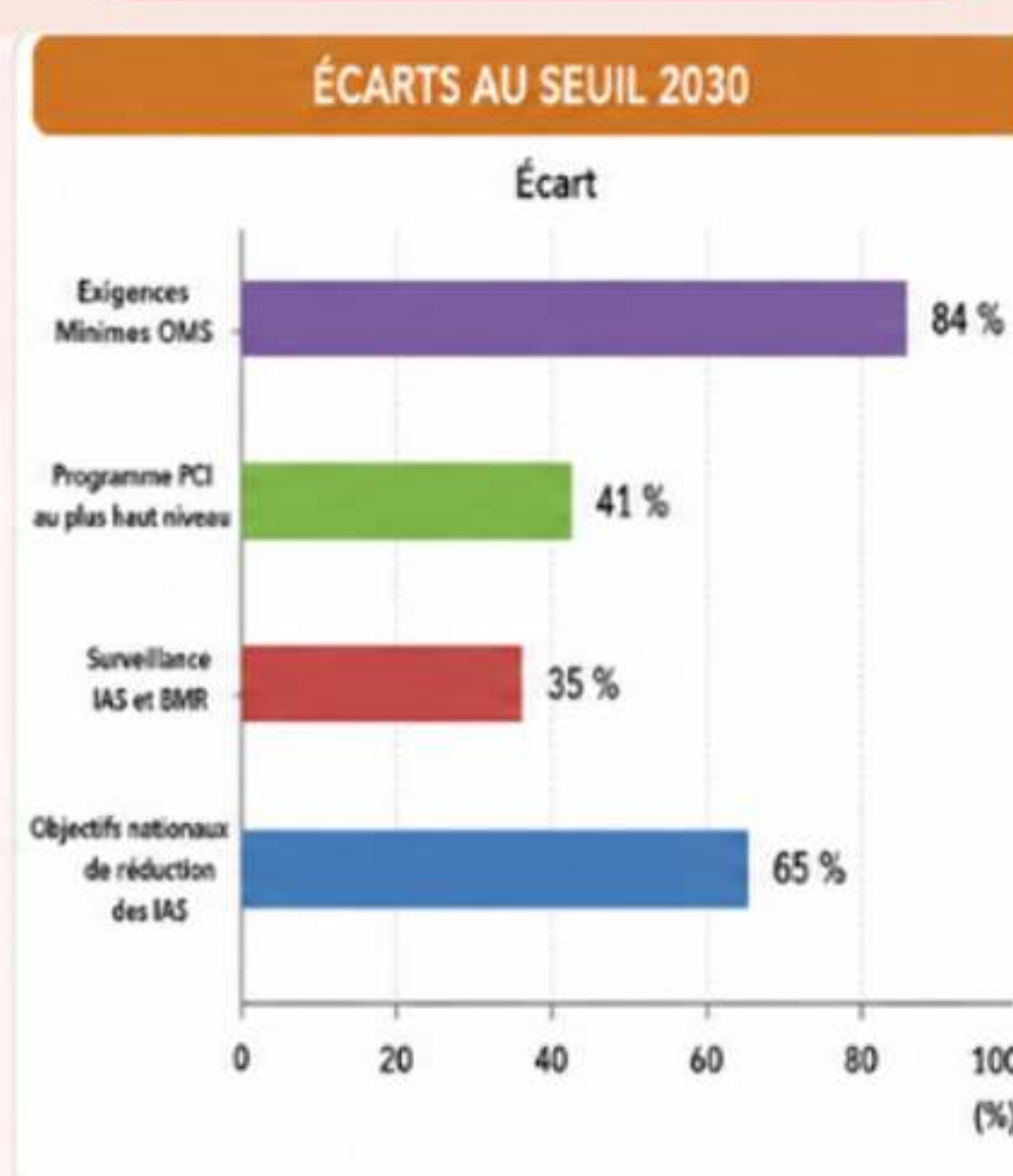
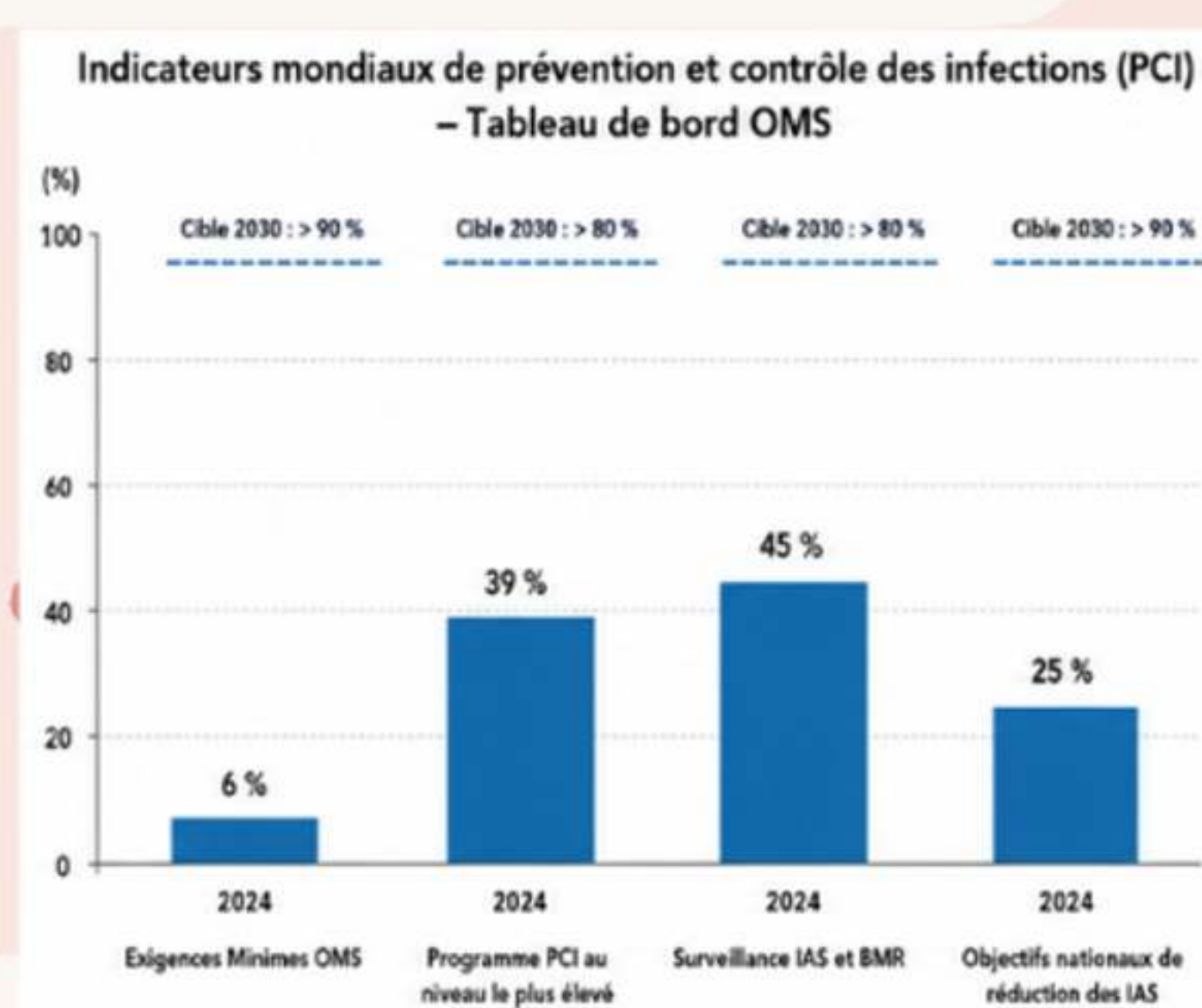
OBJECTIFS

Ce travail vise à analyser les indicateurs mondiaux de l'OMS relatifs à la prévention des IAS, à évaluer les écarts par rapport aux cibles fixées pour 2030 et à proposer des solutions technologiques innovantes susceptibles d'en accélérer l'atteinte.

MÉTHODOLOGIE

Les indicateurs du programme de PCI contribuant à la prévention des IAS ont été comparés aux cibles fixées pour 2030 afin d'identifier les principaux écarts de performance.

RÉSULTATS



CONDITIONS DE RÉUSSITE POUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS 2030

- 1 GOUVERNANCE SOLIDE**
- 2 SURVEILLANCE DE QUALITÉ**
- 3 RESSOURCES HUMAINES**
- 4 FINANCEMENT ADÉQUAT**

Technologies Innovantes

1. SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

- Centralise automatiquement des données provenant du dossier patient, du laboratoire et/ou des systèmes de surveillance.

COMMENT IL AIDE LA PCI

Repère plus rapidement les signaux d'IAS/RAM, standardise la surveillance et facilite les alertes et l'investigation par l'équipe PCI

LIMITES

Qualité et interopérabilité des données ; un signal informatique ne remplace pas la validation épidémiologique.

2 • INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- analyse de grands volumes de données pour reconnaître des profils associés à un risque ou à une infection et produire un score/alerte

COMMENT IL AIDE LA PCI

Peut prioriser les dossiers à vérifier, soutenir la détection précoce, la stratification du risque et l'aide à la décision

LIMITE PRINCIPALE

Validation externe, qualité des données, biais, explicabilité et intégration réelle dans les workflows restent déterminants

3 • TABLEAU DE BORD DÉCISIONNEL

- Transforme les données de surveillance en indicateurs visuels, tendances, comparaisons et alertes compréhensibles

COMMENT IL AIDE LA PCI

Permet de voir rapidement où se situe l'écart, de cibler une unité, de suivre les actions et de fournir un feedback aux équipes

LIMITE PRINCIPALE

La valeur dépend de la qualité des données, de la fréquence de mise à jour et de la capacité de l'équipe à agir sur les écarts

4 SUIVI AUTOMATISÉ DE L'HYGIÈNE DES MAINS

Des capteurs/dispositifs électroniques enregistrent certains événements liés à l'hygiène des mains et peuvent fournir un feedback.

COMMENT IL AIDE LA PCI

Produit des données continues et standardisées, facilite le feedback et permet d'identifier les situations nécessitant une amélioration.

LIMITE PRINCIPALE

Coût, acceptabilité, vie privée, contraintes techniques ; les preuves à long terme restent insuffisantes pour une adoption généralisée

5 • ROBOT DE DÉSINFECTION UV-C

- Après le nettoyage, le robot émet des UV-C pendant une durée/dose définie afin d'inactiver les microorganismes exposés

COMMENT IL AIDE LA PCI

Ajoute une étape de décontamination environnementale dans certaines situations et peut compléter le nettoyage/désinfection manuels.

LIMITE PRINCIPALE

Les zones masquées sont moins exposées ; la technologie ne remplace pas le nettoyage et peut nécessiter une supervision technique

CONCLUSION

Les progrès actuels restent insuffisants pour atteindre les objectifs fixés pour 2030. L'intégration des technologies intelligentes représente une opportunité majeure pour renforcer durablement la prévention des IAS, à condition d'être associée à une gouvernance solide, une surveillance de qualité, des ressources humaines et un financement adéquats.

RÉFÉRENCES

- Organisation mondiale de la Santé. Global IPC Progress Tracker. Genève: OMS; 2024–2026
- World Health Organization. Global report on infection prevention and control 2024. Geneva: WHO; 2024
- Cozzolino et al , Artif Intell Med. 2025;165:103137
- Lin et al., 2026; PMID 42013060
- Maugeri et al, J Hosp Infect. 2025;159:32–41
- Blais R et al,Healthcare Quarterly. 2009;12(Spec No):161–167